



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DA SAÚDE

4.ª CRS - SANTA MARIA

Tel. (51)32885801 / 4crs@saude.rs.gov.br

DELIBERAÇÃO CIR Nº 30 - CIR VERDES CAMPOS E ENTRE RIOS – 4ª CRS

A Comissão Intergestores Regional Conjunta - das Regiões Verdes Campos e Entre Rios, no uso de suas atribuições legais, DELIBERA:

- Os Critérios para Atendimento nas Maternidades de Risco Habitual e Alto Risco da 4ª CRS, conforme documento em anexo.

Santa Maria, 25 de outubro de 2025.

Fabrícia Ennes da Silva Costa
Delegada Regional de Saúde
ID 4595246
4ª CRS - Santa Maria/RS



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DA SAÚDE

4.ª CRS - SANTA MARIA

Tel. (51)32885801 / 4crs@saude.rs.gov.br

Critérios para Atendimento em Maternidade de Alto Risco e Risco Habitual da 4ª CRS

Diante das dificuldades enfrentadas no fluxo das gestantes para atendimento nas maternidades da 4ª Coordenadoria Regional de Saúde (4ª CRS), foi constituído um Grupo de Trabalho composto por enfermeiros, médicos obstetras e gestores das maternidades de referência (Hospital Universitário de Santa Maria, Hospital Casa de Saúde e Grupo Hospitalar de Santiago) bem como por profissionais das áreas técnicas da Saúde da Mulher, da Criança e das IST/HIV, a fim de atualizar o documento inicial de 2019.

O grupo buscou consenso, sintetizado neste documento, com o objetivo de orientar os profissionais que atendem a rede materno-infantil quanto aos critérios clínicos para atendimento nas maternidades de alto risco e risco habitual das regiões 1 e 2. As situações mais comuns estão descritas no presente documento, porém outras podem não estar contempladas, sendo necessário contato com os serviços para definição do encaminhamento mais apropriado, evitando a peregrinação da gestante entre os serviços.

Atualização deverá ser realizada de acordo com a necessidade detectada entre os profissionais e os serviços que compõe a rede.

É importante ressaltar que as pacientes obstétricas devem ser transferidas para os serviços de referência de forma responsável (contato com a referência, estabilização da paciente, relatório clínico, transporte adequado).

Os critérios estão descritos no quadro abaixo e foram aprovados em Reunião da Comissão Intergestores Regional das Regiões Verdes Campos e Entre Rios no dia 25 de Novembro de 2025.

CRITÉRIOS PARA ATENDIMENTO EM MATERNIDADE DE ALTO RISCO E RISCO HABITUAL

	Risco Habitual	Alto Risco
1- Idade Gestacional: Trabalho de Parto Pré-termo/ Ruptura Prematura de Membranas - RUPREME	≥37 semanas e 0 dias (com datação < 20 semanas) ≥38 semanas e 0 dias (com datação ≥20 semanas)	< 37 semanas e 0 dias (com datação < 20 semanas) < 38 semanas e 0 dias (com datação ≥20 semanas)
2- Idade Gestacional acima de 40 semanas	< 42 semanas	≥ 42 semanas
3- Doença Hipertensivas	Hipertensão prévia, pré-eclâmpsia ou hipertensão gestacional na ausência de critérios de gravidade.	Hipertensão prévia, pré-eclâmpsia ou Hipertensão gestacional na presença de: • Controle hipertensivo inadequado a despeito de intervenção medicamentosa com >2 fármacos distintos em dose máxima. • Crise hipertensiva PAS (pressão arterial sistólica) 160 e/ou PAD (pressão arterial diastólica) 110 • Sintomatologia ou alterações laboratoriais sugestivas de PE (pré-eclâmpsia) grave ou Eclâmpsia • Associação com demais patologias (Ex: Diabete Mellitus Prévia, Diabete Mellitus Gestacional em uso de insulinoterapia) • Distúrbios de crescimento (Ex.: Restrição do Crescimento Fetal – RCF ou Pequeno para Idade Gestacional -PIG)
4- Diabetes Mellitus	Diabetes Mellitus Gestacional -DMG na ausência de: • Insulinoterapia • Distúrbio de crescimento fetal (Ex: Macrosomia ou Restrição do Crescimento Fetal - RCF)	Diabetes Mellitus Prévio -DMP Diabetes Mellitus Gestacional - DMG na presença de: • Insulinoterapia • Distúrbio de crescimento fetal (Ex: Macrosomia ou Restrição do Crescimento Fetal – RCF)

5- Anemia	Anemia Leve ($Hb \geq 10$) Anemia Moderada ($Hb \geq 7$) na ausência de critério de gravidade. (com presença de unidade transfusional no serviço)	Anemia Moderada ($Hb \geq 7$) na presença de: • Distúrbio de crescimento (Ex.: RCF ou PIG) • Anemia não ferropriva • Refratariedade a reposição oral de ferro • Patologia de base associada (Ex.: Cardiopatia, Nefropatia, Pneumopatia...) Anemia grave ($Hb < 7$) independente de patologia de base. Anemia associada a sintomatologia ou instabilidade hemodinâmica.
6- Infecções	Pielonefrite na ausência de critérios de gravidade.	Pielonefrite na presença de: • Instabilidade hemodinâmica • Patógeno multiresistente • Critério de sepse • Comprometimento orgânico agudo (Ex.: IRA) Corioamnionite
7- Distúrbios de crescimento	Macrossomia fetal na ausência de Diabetes Mellitus Gestacional- DMG PIG (excluído restrição do crescimento fetal) na ausência de: • Doença hipertensiva • Anemia materna • Patologia de base associada (Ex.: Cardiopatia, Nefropatia, Pneumopatia, Doença Autoimune...) * Para diferenciação entre Restrição de Crescimento Fetal e Pequeno para Idade Gestacional é necessário DOPPLER	Restrição do Crescimento Fetal -RCF Macrossomia fetal na presença de Diabetes Mellitus Gestacional- DMG Pequeno para a Idade Gestacional -PIG na presença de: • Doença hipertensiva • Anemia materna • Patologia de base associada (Ex.: Cardiopatia, Nefropatia, Pneumopatia, Doença Autoimune...) * Para diferenciação entre RCF e PIG é necessário DOPPLER
8- Cirurgias	1 cesariana prévia há mais de 18 meses	1 cesariana prévia há menos de 18 meses ≥ 2 cesarianas prévias

Ginecológicas/Obstétricas		Miomectomia prévia Métroplastia prévia
9- STORCH - Sífilis, Toxoplasmose, Rubéola, Citomegalovírus e Herpes Simples	Infecção de STORCH na gestação na ausência de: • Infecção fetal documentada (Malformação identificada em US ou PCR positivo) • Tratamento inadequado ou incompleto • Distúrbio de crescimento (Ex.: PI&G e ou RCF)	Infecção de STORCH na gestação na presença de: • Infecção fetal documentada (Malformação identificada em US ou PCR positivo) • Tratamento inadequado ou incompleto • Distúrbio de crescimento (Ex.: PI&G e ou RCF)
10- Outras infecções:	Estreptococo do Grupo B (EGB)+ ou fatores de risco para doença estreptocócica neonatal; HIV+ (carga viral acima de 34 semanas inferior a 1000 cópias); Hepatite B+; Hepatite C+; HTLV+	SIDA
11- Hemorragias de primeiro trimestre	Abortamento em curso/ retido / incompleto (Com unidade transfusional no serviço)	Abortamento infectado / Gestação ectópica Doença trofoblástica gestacional
12- Hemorragias de segundo e terceiro trimestre	Se ≥ 37 semanas e 0 dias (Datação < 20 semanas) ou ≥ 38 semanas e 0 dias (Datação ≥ 20 semanas) e estabilidade hemodinâmica na ausência de múltiplas cesarianas prévias.	Se < 37 semanas e 0 dias (Datação < 20 semanas) ou < 38 semanas e 0 dias (Datação ≥ 20 semanas) e instabilidade hemodinâmica e/ou múltiplas cesarianas prévias.
13- Acretismo Placentário		Suspeita/diagnóstico de acretismo placentário atual: • implantação placentária prévia ou anterior baixa • lacunas vasculares dentro da placenta • perda da zona hipocogênica normal entre placenta e miométrio • diminuição da espessura do miométrio retroplacentário (menor que 1mm), anormalidades da interface uterina e serosa vesical • Vascularização placentária com fluxo turbulento também é um sinal fortemente sugestivo
14- Abdome agudo na gestação		Suspeitas de abdome agudo na gestação devem ser encaminhadas para alto risco.
15- Tromboembolismo venoso		Suspeitas de TEV devem ser encaminhadas para alto risco.
16- Malformações fetais	Malformações fetais de baixo risco, quando isoladas: • Arteria Umbelical Única	Suspeitas de malformações fetais mais complexas ou combinação de malformações devem ser encaminhadas

	- Sinal de Golf ball - Dilatação pielocalicial leve	para alto risco.
17- Trauma	Traumas leves (Ex.: queda da própria altura)	Politrauma (Ex.: acidente de automobilístico, violência doméstica, FAB e FAF)
18- Obesidade	IMC pré-gestacional $>30 \text{ kg/cm}^2$ com ganho ponderal durante a gestação inferior a 20 kg IMC pré-gestacional $\geq 35 \text{ kg/cm}^2$ com ganho ponderal durante a gestação inferior a 10 kg	IMC pré-gestacional $>30 \text{ kg/cm}^2$ com ganho ponderal durante a gestação superior a 20 kg IMC pré-gestacional $\geq 35 \text{ kg/cm}^2$ com ganho ponderal durante a gestação superior a 10 kg IMC pré-gestacional $> 40 \text{ kg/cm}^2$
19- Aloimunização		Suspeitas de aloimunização devem ser encaminhadas para alto risco
20- Distúrbios de líquido amniótico		Suspeita de oligodrâmnio ($MB < 2 \text{ cm}$) e polidrâmnio ($ILA > 25 \text{ cm}$) devem ser encaminhadas para alto risco excluído Ruptura Prematura de Membranas (RUPREME) a termo
21- Uso de Substâncias e Transtornos Psiquiátricos (*)	Uso de substâncias ocasional na ausência de complicações gestacionais associadas ou vulnerabilidade social. Patologias psiquiátricas estabilizadas e em acompanhamento.	Dependência química (Em regime de internação hospitalar ou não). Uso de substâncias ocasional associado a complicações gestacionais ou vulnerabilidade social. Transtornos psiquiátricos descompensados (Ex.: mania e ideação suicida)
22- Número de consultas de pré-natal	Pré natal iniciado até 24 semanas e pelo menos 6 consultas de pré-natal.	Pré natal iniciado após 24 semanas 5 ou menos consultas de pré natal.
23- Traumas Previos		Sequelas de traumas e procedimentos complexos que afetem o risco obstétrico
24- Doenças Neurológicas		Epilepsia de difícil manejo, acidente vascular cerebral com sequelas, déficits motores graves
25- Cardiopatias maternas		Gestantes com cardiopatias (valvulopatias, arritmias e endocardite) ou infarto agudo do miocárdio
26- Nefropatias		Nefropatias graves
27- Doenças hematológicas		Doença falciforme, púrpura trombocitopenia idiopática, talassemia e coagulopatias

* Uso de Substâncias e Transtornos Psiquiátricos: Fluxo para internação de gestantes e puérperas em situação de uso abusivo e nocivo de substâncias psicoativas está em construção por grupo constituído dos serviços de maternidade e saúde mental.